# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 91407
SERVICIO : UNIDAD EMERGENCIAS
FECHA : 2024-08-26 17:40:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | : ERNA ROSA BAHAMONDEZ CARO | | | RUN | : 4.197.510-5 |
| F.Nac | : 26-05-1937 | Edad | : 87 AÑOS, 3 MESES | Género | : Femenino |
| Dirección | : OSSA 762 | | | Comuna | : SAN CARLOS |
| Previsión | : FONASA B | Teléfono | : 0 | | |
| Fecha Ingreso | : 26-08-2024 | Fecha Egreso | : 2024-08-26 17:40:00 | Causal | : MEDICA |
| Condición | : VIVO | Destino | : HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA | Derivación | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R73.9-HIPERGLICEMIA, NO ESPECIFICADA

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Hiperglicemia corregida
Anemia severa transfundida
Deterioro psicorgánico avanzado
Dependencia severa
Bronquitis aguda

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J20-BRONQUITIS AGUDA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J20-BRONQUITIS AGUDA. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. D46.4-ANEMIA REFRACTARIA, SIN OTRA ESPECIFICACION (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con am de DM2, HTA , ACV secuelado , demencia avanzada, dependiente severo; quien ingresa el dia 25/08 por hiperglicemia de 573mg/dl. al ciclo vital ingresa normotensa 109/59 mmhg, leve taquicardica hasta 102, sat 99% ambiental, examenes de laboratorio destacan glicemia 509, Hb 4.1, Hto 14%, creatinina 1.5 , GSV PH 7.40 HCO3 17.3 BE -6.1 osmolalidad de ingreso 310, orina leucocitos 15-25 x campo, piocitos 40-50 x campo, cuerpos cetónicos (-), Rx de toráx no impresionan imagenes de consolidación, se inicia manejo de hiperglicemia y transfusión de GR : durante volemizacion e insulinoterapia paciente evoluciona con hipoglicemia ( 46mg/dl/) por lo que se inicia sol glucosada al 10% a 40 cc / hora y se dice ingreso hospitalario por inestabilidad metabolica en contexto de posible foco urinario y respiratorio. Durante estadía hospitalaria evoluciona HDM estable al ciclo vital afebril, normotensa PA 166/89 mmhg, normocardica FC 82, sat 94& fio2 21% HGT 101 mmg/dl rr2t ss mp+ con roncus y sibilantes bilaterales, leve uso de musculatura accesoria, abdomen blando indoloro rha+, extremidades con edema+/+++ . Examenes de laboratorio control: Hb 8.6 Hcto 26.9 Gb 10200 plaquetas 325, seg 73% linf 16% glicemia 106 crea 1.2 na 143 k 4.5 cl 120. En vista de correccion de hiperglicemia, anemia en rango no transfusional y estabilidad clinica se decide Hospitalizacion domiciliaria para continuar con manejo ATB, y kinesioterapia respiratoria, motora y seguimiento por fonoaudiologia.

## PLAN DE MANEJO:

Hospitalización Domiciliaria
Regimen papilla por SNG
Ceftriaxona 2 gr ev cada 24 horas por 7 dias
Metoclopramida 10mg 1 comp vo cada 8 horas SOS nauseas o vómitos
Famotidina 40mg 1 comp vo cada 24 horas ( am) por 7 dias

Bromuro de ipratropio 3 puff cada 6 horas con Aero cámara por 7 dias
Paracetamol 500mg 2 comp por SNG cada 6 horas SOS fiebre o dolor
Metformina tab 500mg 1 comp cada 12 horas por SNG por 7 dias
Kine respiratoria y motora 1 vez al dia
Seguimiento por fonoaudiólogo
Pendiente Rescatar urocultivo
Derivar a urgencias SOS

## INDICACIONES AL ALTA

1. HODOM
2. Rescatar urocultivo 72 horas
3. Control por equipo de postrados para evaluar reinicio de insulinoterapia

Control en: 3 días en OTRO

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO